COMPRENDRE • UE A2 / S1

Organisation et normes

Profession infirmière, repères juridiques et déontologie • CM de Patrick Karsenti

Une profession encadrée pour protéger les personnes

L'exercice infirmier s'inscrit dans un cadre de santé publique. Les textes définissent les conditions d'exercice et les obligations professionnelles. Deux niveaux structurent la profession : les institutions publiques élaborent et mettent en œuvre les politiques de santé ; l'Ordre contribue à la régulation déontologique de la profession.

ACTEUR	REPÈRE À CONNAÎTRE	CE QUE CELA CHANGE POUR L'IDE
Ministère chargé de la Santé	Fixe les orientations nationales et les règles de santé publique ; le cadre de formation et du diplôme d'État relève de l'État.	Les règles nationales s'appliquent quel que soit le lieu d'exercice.
ARS	Met en œuvre la politique de santé à l'échelle régionale, en tenant compte des besoins du territoire.	Participe à l'organisation et à la régulation régionales de l'offre de santé.
Ordre national des infirmiers (ONI)	Ordre professionnel institué par le Code de la santé publique ; inscription obligatoire pour les infirmiers habilités à exercer en France, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.	Veille au respect des règles déontologiques, accompagne et représente la profession, participe à la discipline ordinale.

Réflexe de stage

Une consigne ou une habitude de service ne remplace jamais le cadre légal, les règles professionnelles et l'évaluation de la situation du patient. En cas de doute : vérifier, demander conseil, tracer et alerter selon la situation.

Public / privé : identifier le cadre

ÉTABLISSEMENT PUBLIC	STRUCTURE PRIVÉE
Le droit public et les règles de la fonction publique hospitalière peuvent s'appliquer. Les litiges avec l'administration relèvent en principe de la juridiction administrative.	Le droit privé et le Code du travail régissent notamment les relations salariées ; les litiges civils relèvent en principe de l'ordre judiciaire.

Ces repères généraux dépendent de la nature du litige, du statut et des faits. Le mot « responsabilité » recouvre plusieurs voies distinctes.

COMPRENDRE • RESPONSABILITÉS

Un fait peut relever de plusieurs voies

Distinguer le but de la procédure et la personne ou l'institution concernée.

Les normes et la responsabilité

Les normes s'organisent selon des niveaux : la Constitution et les normes constitutionnelles, les engagements internationaux et européens applicables, la loi, puis les règlements (décrets, arrêtés…). Un texte inférieur doit respecter les normes qui lui sont supérieures. Au quotidien, consulter la version en vigueur et les règles propres à l'acte plutôt que raisonner à partir d'un schéma simplifié.

VOIE	QUESTION / FINALITÉ	REPÈRE POUR LE STAGE
Civile / administrative	Un dommage doit-il être réparé/indemnisé ?	La juridiction dépend notamment du statut et du cadre d'exercice. En établissement public, la responsabilité de l'hôpital peut être engagée ; la faute personnelle détachable du service obéit à un régime particulier.
Pénale	Une infraction prévue par la loi a-t-elle été commise ?	La responsabilité pénale est personnelle. Exemple : blessures involontaires si les éléments de l'infraction sont réunis.
Disciplinaire / ordinale	Une obligation professionnelle ou déontologique a-t-elle été méconnue ?	La sanction dépend de l'employeur ou, pour l'ordre, des juridictions ordinales et de la procédure applicable.

À retenir

Un même événement peut entraîner plusieurs procédures, aux objectifs différents. Une responsabilité n'exclut pas automatiquement les autres. Les faits, les textes applicables et le statut comptent.

Responsabilité IDE : gestes concrets

Agir dans son champ de compétences ; connaître les règles applicables aux actes ; demander une clarification devant une prescription ou une consigne ambiguë ; signaler un risque ; assurer une surveillance adaptée et alerter en cas d'évolution. Documenter les faits avec précision et sans jugement de valeur.

Chaîne de prudence

Je repère → j'évalue → je sécurise → je transmets/alerte → je trace les faits et les actions. Si l'urgence survient, les règles de secours et les compétences infirmières s'appliquent.

COMPRENDRE • DÉONTOLOGIE

Les devoirs envers la personne soignée

Des obligations juridiques guident la relation, les soins et le travail en équipe.

Principes au lit du patient

PRINCIPE	APPLICATION INFIRMIÈRE
Dignité & intimité	Respecter la personne, sa pudeur, sa vie privée et celle de ses proches ; expliquer le soin et préserver l'intimité.
Égalité / non-discrimination	Écouter, conseiller et soigner avec la même conscience, sans distinction fondée notamment sur l'origine, la situation, les croyances, le handicap, l'âge, le sexe ou la santé.
Information & consentement	Contribuer à l'information relevant de ses compétences ; rechercher un consentement libre et éclairé pour les soins, respecter le refus et le cadre prévu par la loi.
Compétence & prudence	Maintenir ses connaissances ; agir avec compétence et attention ; en urgence, réaliser les gestes relevant de son pouvoir et orienter vers la prise en charge adaptée.

Secret professionnel : partager juste ce qui est nécessaire

Le secret protège les informations concernant la personne, qu'elles aient été confiées, observées, entendues ou comprises. Dans une même équipe de soins, seuls les éléments strictement nécessaires à la coordination, à la continuité ou au suivi peuvent être partagés. Hors de l'équipe, le partage nécessite en principe le consentement préalable, sous réserve des cas prévus par la loi. Vérifier le destinataire, le canal et la pertinence avant toute transmission.

Règle pratique

Se demander : « Cette personne participe-t-elle à la prise en charge ? A-t-elle besoin de cette information pour le soin ? Quel est le minimum utile à transmettre ? » Éviter les conversations dans les lieux publics et les supports non sécurisés.

Confraternité et refus de soins

Entre professionnels : respect, entraide et échanges professionnels au service de la sécurité ; traiter les désaccords sans dénigrer un collègue devant le patient. Un infirmier qui accepte un soin doit en assurer la continuité, sauf exceptions prévues par les textes. Hors urgence, une décision de refus/interruption doit être motivée, annoncée au patient et organisée sans abandon de la personne. Ne pas interrompre un soin sans relais sûr.

COMPRENDRE • TRACER & SE PROTÉGER

Dossier de soins et violences

Assurer continuité des soins, sécurité et traçabilité factuelle.

Écrire pour soigner et rendre compte

Le dossier rassemble les informations utiles au parcours et soutient la coordination. Une transmission exploitable est datée, attribuable, lisible et pertinente. Écrire au plus près du soin ; distinguer observation, parole rapportée, mesure, décision, action et résultat ; respecter les règles locales de tenue et de confidentialité.

À TRACER	COMMENT
Évaluation / surveillance	Paramètres et observations pertinents, évolution, heure, contexte et comparaison si utile.
Soins / traitements	Acte réalisé, heure, réponse du patient ; écart, incident ou alerte et suite donnée.
Refus / information	Propos et décision de la personne avec ses mots si utile, information délivrée, évaluation du risque, interlocuteurs alertés, continuité organisée.
Incident / événement indésirable	Faits observables, chronologie, témoins utiles et mesures prises ; suivre aussi la procédure institutionnelle de signalement.

Trace fiable

Écrire factuellement, sans jugement (« patient crie et repousse le plateau » plutôt que « patient agressif »). Ne jamais falsifier ni antidater. Corriger selon la procédure prévue, en conservant la traçabilité.

En cas de violence envers un soignant

1 • SÉCURISER	2 • SIGNALER / TRACER	3 • SE FAIRE ACCOMPAGNER
Mettre à l'abri la personne, les patients et l'équipe ; demander de l'aide et les secours si nécessaire.	Prévenir la hiérarchie ; rédiger un compte rendu factuel ; utiliser le circuit interne de signalement (événement indésirable/violence) et conserver les éléments utiles.	Selon le contexte, soins et constat médical, dépôt de plainte possible, soutien institutionnel et demande de protection fonctionnelle pour l'agent public selon les conditions applicables.

La protection fonctionnelle n'est pas une prise en charge automatique et identique dans tous les cas : l'agent public la demande à son administration ; la décision dépend du cadre légal et des circonstances. Le cours rappelle aussi que certaines violences visant des soignants peuvent relever de circonstances aggravantes prévues par le droit pénal : la qualification dépend de l'infraction et des faits. Le signalement à l'ONVS est un dispositif de remontée et d'analyse des violences en santé, distinct d'une plainte pénale.

Repères officiels : Code de la santé publique, art. L.4312-1 ; R.4312-1 à 13, 23–24 et 43 ; art. L.1110-4. Légifrance, textes en vigueur consultés le 12/10/2026. Source pédagogique : Moodle, « Organisation et normes — Patrick Karsenti », UE A2/S1, 22/09/2026.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006178629/ •
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031929082